

05 - 05- Molluscum contagiosum - Pr. Hocar

(0:00 - 0:33)

Je vais vous présenter aujourd'hui le cours du molluscum contagiosum. Ce cours s'inscrit dans les dermatoses virales et ressemblent aux infections à lumen papulum averus par le caractère solide de la lésion élémentaire, à savoir la papule ombiliquée qui est quasi spécifique du molluscum contagiosum. Au terme de ce cours, vous devriez être aptes à diagnostiquer un molluscum contagiosum et à connaître les modalités thérapeutiques à proposer chez un patient présentant des lésions de molluscum contagiosum.

(0:34 - 1:07)

Le molluscum contagiosum est une tumeur cutanée binine d'origine virale décrite pour la première fois par Thomas Batman en 1914. L'agent responsable était un membre de la famille Poxvirus, de la sous-famille Chordopoxvirine. Le mollicipoxvirus est un virus à ADN fréquemment retrouvé chez les enfants entre 3 et 16 ans, mais aussi on peut le retrouver chez les patients immunodéprimés et plus rarement chez les adultes immunocompétents.

(1:07 - 1:51)

Le diagnostic est généralement aisé, mais le choix thérapeutique est parfois problématique à cause des récurrences, de la dissémination et aussi de l'immunodépression. Le molluscum contagiosum est un mollicipoxvirus qui fait partie de la famille des mollicipoxvirus, c'est le seul virus spécifique à l'homme. Le molluscum contagiosum est une infection cutanée et plus rarement myqueuse, sporadique ou endémique, particulièrement fréquente dans les communautés d'enfants, chez les immunodéprimés de tous types et dans une moindre mesure chez l'immunocompétent qui possède une relative diminution de l'immunité cellulaire vis-à-vis de ce virus.

(1:51 - 2:31)

La promiscuité et les altérations de la barrière épidermique sont des facteurs favorisant la dissémination du virus, ce qui explique aussi l'incidence plus élevée chez les patients atteints de l'hermatite atopique. La contamination du molluscum contagiosum est interhumaine et peut se faire par contact direct, soit dans les piscines et en particulier les piscines scolaires ou par l'intermédiaire d'objets essuyés, comme les éponges de bain et serviettes utilisées par les individus infectés. Il existe une auto-inoculation par grattage et par phénomène de Kovner.

(2:32 - 2:59)

La période d'incubation varie entre deux semaines et six mois et l'évolution vers la guérison se fait spontanément en l'espace de quelques mois à deux ou trois ans. Le molluscum contagiosum

est présent chez 80% des patients avant l'âge de 8 ans. Sur le plan clinique, ça réalise une petite papule de couleur chair, ferme, hémisphérique et ombiliquée en son centre.

(2:59 - 3:10)

Elle mesure entre 1 et 6 mm. Parfois, la tumeur peut être volumineuse et aura implanté sur un pédicule étroit. Elle ressemble alors à un acrocordant.

(3:11 - 3:29)

Le molluscum contagiosum est fréquemment retrouvé sur la région céphalique, le tronc, les membres supérieurs et la zone génitale. Les régions génitales sont plus fréquemment atteintes chez les patients séropositifs pour le VIH. La muqueuse buccale n'est pas épargnée.

(3:32 - 4:10)

La lésion cutanée peut prendre un aspect de type gion, une forme tumorale ou une forme feronculoïde ou un type de folliculite. Sur ces photos, on peut voir des papules ombiliquées à son centre avec un aspect typique de molluscum contagiosum et on voit la localisation sur le scalp qui est possible chez l'enfant mais aussi chez l'adulte et l'aspect de lésions multiples sur le scalp. Cette photo illustre l'aspect de molluscum contagiosum avec des lésions ombiliquées, des lésions d'âge différent.

(4:11 - 4:36)

On a des petites papules, on a les autres lésions qui sont inflammatoires, certaines sont croûteuses, certaines sont nécrotiques. Le caractère évolutif de ces lésions oriente vers l'auto-élimination, la guérison spontanée si on arrive au stade inflammatoire. Il n'y a pas d'acharnement thérapeutique à proposer, les lésions vont s'éliminer spontanément.

(4:37 - 5:15)

Pour vous montrer le caractère profus de molluscum contagiosum, on peut avoir une ou deux lésions mais aussi on peut avoir une vingtaine ou trentaine de lésions sur le tronc, sur les membres, très profuses, très profusionneuses, très gênantes, source de surinfection bactérienne et source de malaise, d'insomnie qui va amener l'enfant à consulter. À ce moment-là, on peut proposer un cure-tâche pour éliminer les lésions. Un autre aspect qu'on peut rencontrer au cours d'un molluscum contagiosum, c'est les lésions géantes, pseudo-tumorales, pédiculées, aussi caractéristiques du molluscum contagiosum.

(5:16 - 5:53)

Si on arrive à avoir la lésion ombilique caractéristique, tant mieux pour le diagnostic. Si on n'arrive pas à l'avoir, on peut s'aider d'un dermoscope qui va faire grandir les lésions, surtout les

micropapules, pour voir cette caractéristique ombilication typique du diagnostic de molluscum. Cette photo aussi montre un autre stade évolutif de lésions de molluscum contagiosum, c'est des lésions après élimination, donc la phase inflammatoire, puis l'élimination des lésions papilleuses, laissant place à des petites cicatrices éparpillées sur le tronc.

(5:55 - 6:56)

L'as de grand enfant présente une forme profuse de lésion de molluscum contagiosum, surtout éparpillée sur le visage, sur la partie médio-faciale, source de disgrâce esthétique, source de gêne au quotidien. Là aussi, l'indication de proposer un traitement est souhaitable pour améliorer l'estime de soi de cet enfant et la qualité de vie de façon globale. Cette photo pour vous montrer les localisations atypiques particulières, et là c'est un molluscum contagiosum sur une paupière inférieure, c'est une gêne particulière et aussi sur le plan thérapeutique, il ne faut pas être trop agressif, de peur de toucher l'œil par des traitements agressifs, surtout chimiques, donc faire attention avant de proposer un traitement sur le visage et surtout sur la paupière inférieure.

(6:57 - 7:23)

Le molluscum contagiosum, c'est un virus qui a un tropisme cutané, mais aussi myquieux, on peut avoir des localisations oculaires sur le bord libre des paupières, mais aussi sur les conjonctives et la cornée. C'est une dermatose, parmi les dermatoses prurigineuses, mais le prurit variable. Il faut noter que la régression spontanée est la règle en matière de molluscum contagiosum et se passe en 2 à 3 mois.

(7:24 - 7:58)

Le diagnostic positif peut parfois être difficile et on est amené à discuter certains diagnostics différentiels. En cas de doute, la dermoscopie permet un diagnostic clinique plus précis, tandis qu'une étude histologique permet de confirmer le diagnostic. Le molluscum contagiosum étant parfois associé à d'autres lésions de type kystipidermie, névuse, mais aussi, il peut être aussi discuté avec les papillons buériques, les adénomes sébacées, un carcinome baso-cellulaire nodulaire ou un acrocordon.

(7:58 - 8:24)

Le molluscum contagiosum peut mimer des tumeurs de type histiocytose aux aux granulones, surtout chez l'enfant où ces deux lésions peuvent exister. Chez le sujet séropositif pour le VIH, il faudra exclure une cryptococose qui peut se manifester par des lésions papilleuses type molluscum contagiosum life. Nous arrivons maintenant à la prise en charge.

(8:25 - 8:38)

Divers traitements sont envisageables. Il s'agit de techniques mécaniques, physiques ou médicamenteuses locales ou systémiques. Chez l'immunocompétent, l'abstention thérapeutique

peut être envisageable.

(8:38 - 9:05)

La guérison spontanée survenant en quelques mois aux allées. Chez les patients immunodéficients au séropositif pour le VIH, la thérapeutique est souvent difficile et les récives sont fréquentes, c'est pourquoi l'association de plusieurs techniques est préconisée. En matière de prise en charge du molluscum contagiosum, on peut être amené à proposer des traitements physiques comme le curetage.

(9:05 - 9:37)

C'est le traitement du choix au moyen d'une curette de broc tranchante et très efficace mais douloureuse. On peut appliquer de façon préalable une pommade anesthésiante type MLA ou aniderme qui peut améliorer le confort du patient avec les précautions d'usage afin d'éviter une toxicité sous forme de métoglobuline. On peut proposer la cryothérapie mais c'est un traitement qui ne doit plus être retenu en raison des résultats inconstants et l'apparition de cicatrices dyschromiques sur les peaux pigmentées.

(9:37 - 10:08)

La photothérapie dynamique peut être envisagée, en particulier chez les patients HIV. L'électrocoagulation et le laser CO2 sont des techniques qui doivent être abandonnées en raison du risque de cicatrices qui sont engendrées. À côté des traitements physiques, on peut proposer des traitements médicamenteux topiques, soit la technique vise à la destruction de la lésion, soit il vise à une action immunomodulatrice locale.

(10:08 - 10:23)

On peut proposer le nitrate d'argent à 40% en pâte. C'est un traitement qui semble efficace. Dans une étude portant sur centaines de patients, la guérison est estimée à près de 97% sans effet secondaire.

(10:23 - 10:42)

On peut être amené à proposer la podophylotoxine. Ça a été vendu au Maroc et puis par la suite, il n'y est plus. Pour les patients à la Porte de France, c'est la podophylotoxine à 0,5% appliquée sur les lésions deux fois par jour pendant trois jours consécutifs.

(10:43 - 10:52)

C'est un traitement qui semble donner de bons résultats. On peut proposer l'hydroxyde de potassium. Ça se vend au Maroc sous le pourcentage de 5% en parapharmacie.

(10:53 - 11:14)

Les parents vont appliquer ce traitement à la maison deux fois par jour pendant 14 jours consécutifs jusqu'à inflammation. Les lésions vont se transformer en une lésion croûteuse avec une croûte hémorragique par-dessus. C'est à ce niveau-là que les parents vont arrêter l'application.

(11:15 - 11:30)

L'effet souhaité, c'est induire une inflammation qui va aboutir à l'élimination des lésions. On peut être amené à proposer aussi l'hydroxyde de potassium à un pourcentage de 10%. Mais cette fois, c'est un traitement qui est appliqué par le médecin traitant lui-même.

(11:30 - 11:43)

Donc, on ne peut pas donner 10% aux parents. Et puis, on peut proposer l'acide troclaracétique aussi. Donc, c'est un traitement qui serait appliqué par le médecin ou le pédiatre ou le dermatologue sur les lésions.

(11:43 - 12:07)

On peut proposer des préparations salicylées à 12% qui semblent donner de bons résultats sur les lésions de molluscorps. On peut proposer un immunomodulateur, c'est l'imicumote, qui se vend sous le nom commercial d'Aldara à 5%. C'est un traitement qui, grâce à son potentiel immunomodulateur, possède une efficacité dans le traitement du molluscorps contagieusement.

(12:08 - 12:31)

L'imicumote est un traitement potentiel pour les cas sévères de l'infection à molluscorps contagieusement. Chez les enfants, nous pouvons être curetés, y compris chez les patients immunodéprimés. La fréquence d'application ainsi que la durée doit encore être établie, bien que les études montrent l'efficacité de la molécule, à raison de trois applications par semaine pendant 12 à 19 semaines.

(12:32 - 13:01)

Il est rapporté la survenue de piques épithermiques chez les enfants pendant le traitement à l'imicumote. À côté des traitements physiques, des traitements médicamenteux par destruction locale topique, on a les traitements systémiques. Ces modalités thérapeutiques ne doivent être envisagées que dans les cas particuliers de dissémination importante chez l'immunodéprimé ou chez l'immunocompétent pour qui les traitements topiques physiques ou médicamenteux sont inefficaces.

(13:02 - 13:20)

Ils n'ont pas fait preuve de leur totale efficacité. On peut citer la cimitidine, c'est un antagoniste des récepteurs histaminiques et administré à raison de 40 mg par kg par jour en trois prises quotidiennes. Son mode d'action n'est pas encore connu.

(13:22 - 14:07)

Le sidofibir, l'indinavir et l'oréthonavir, c'est des traitements qui semblent efficaces chez les patients affectés par le VIH, seul ou en combinant, en augmentant le nombre de CD4 de manière significative, assurant une meilleure défense contre le virus. L'essentiel à retenir de ce cours, c'est que le molluscum contagiosum, c'est des infections qui atteignent la population pédiatrique et sont secondaires à l'infection cutanée par un poxvirus qui a un tropisme cutanéux, mais aussi myxieux. C'est un motif fréquent de consultation en pédiatrie et en dermatologie et qui pose un problème de stratégie thérapeutique lorsque les lésions sont nombreuses.

(14:07 - 14:24)

La contagiosité se fait par un contact direct peau à peau dans la majorité des cas et le traitement a comme principe commun la destruction des lésions par différents moyens. Il faut noter que l'indication thérapeutique dépend du nombre de lésions et de la tolérance du traitement.